Anorektalne atrezije in kontinenca

Diana Gvardijančič, Aleš Tomažič
Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

V članku smo predstavili anorektalne atrezije, njihovo klasifikacijo in način kirurške obravnave. Opisali smo tudi pomembne dejavnike za kontinenco in kako kontinenco ocenjujemo pri otrocih. Opisali smo tudi urejanje režima odvajanja z dietami, medikamentozno terapijo ali klistirji.

Retrogradno smo pregledali popise otrok zdravljenih na našem oddelku od januarja 2001 do januarja 2011. V tem času smo operirali 60 otrok. Prikazani so rezultati kontinence pri teh otrocih.

Naši otroci so dobro vodeni in so socialno sprejemljivi in čisti.

Uvod

Anorektalna atrezija prizadene črevo in okolne strukture kot je sfinkter in sluznica na prehodu iz črevesa v kožo. Kljub najboljši popravi zaradi teh anomalij lahko pride do inkontinence. Inkontinenca za blato predstavlja resen problem in lahko izzove socialno nesprejemljivost in pusti psihološke posledice (1).

K zdravljenju inkontinence ni možno pristopiti tako, da bi hitro dokončno odstranili vzroke inkontinence, ampak se opremo na spremembe v načinu življenja, ki spremljajo zdravljenje in ki bodo izboljšale kvaliteto življenja (2).

Izhodišča

Pri plodu z anorektalno atrezijo se nepravilno izoblikuje zadnjik in povezava z danko. Do leta 1990 je veljala klasifikacija Wingspread, ki anorektalne atrezije deli na visoke, intermediarne in nizke glede na mišice medeničnega dna. Sedaj upoštevamo bolj natančno klasifikacijo.

Deklice:

1. anorektalna anomalija s perinealno fistulo;
2. anorektalna anomalija z rektovestibularno fistulo;
3. anorektalna anomalija z rektovaginalno fistulo;
4. anorektalna anomalija brez fistule;
5. rektalna atrezija;
6. kloaka, kjer posebej opredelimo dolžina skupnega kanala.

Dečki:

1. anorektalna anomalija z rektoperinealno fistulo;
2. anorektalna anomalija z rektouretralno fistulo v bulbarnem delu;
3. anorektalna anomalija z rektouretralno fistulo v prostatičnem delu;
4. anorektalna anomalija s fistulo v vrat mehurja;
5. anorektalna anomalija brez fistule;
6. rektalna atrezija

Pri prepoznavanju teh anomalij je vedno najpomembnejši natančen klinični pregled, nato pa imamo čas, da izključimo vse možne spremljajoče napake. Spremljajoče anomalije izključi ultrazvok trebuha,

ki nam pokaže sečila in njihove morebitne nenormalnosti (anomalije). V 18–24 urah po rojstvu se danka tudi že razpne in pokaže se morebitna perinealna fistula. Takrat se odločimo za takojšno operacijo - posteriorno sagitalno anorektoplastiko (PSARP) ali pa za kolostomo. Če še vedno nismo prepričani, za kakšno anomalijo gre, se lahko odločimo za stransko rentgensko slikanje otroka, ki leži na trebuhu s podprtimi boki. Označimo anatomsko lego zadnjika s svinčeno značko. Prikaže se zračni mehur v danki in izmerimo lahko dolžino defekta do kože, kjer je svinčena značka. Pri višjih anomalijah se odločimo za descendostomo in šele po opravljenem distalnem kolostomogramu za dokončno popravo, ki lahko obsega tudi plastiko vagine in uretre (PSARVUP).

Po popolni zacelitvi anorektalnega predela lahko stomo zapremo.

Novorojenček nato odvaja po naravni poti. Dokler uporablja plenice lahko ocenjujemo le pogostost odvajanja in konzistenco blata. Šele med 2. in 4. letom pa preide na odvajanje na »kahlico« ali stranišče in takrat lahko ocenjujemo kontinenco.

Za kontinenco je pomembnih več dejavnikov, ki vsak zase doprinesejo k popolni željeni kontroli nad odvajanjem blata. Trije mehanizmi omogočajo zadrževanje in redno odvajanje:

- Prvi je sfinkterski mehanizem za katerega morajo biti prisotne mišice sfinktra na nivoju anusa in rektuma kot tudi mišice medeničnega dna. Te mišice morajo biti tudi normalno oživčene.
- Drugi je motiliteta črevesa za katero mora biti prisotna normalna peristaltika skozi ozko in široko črevo. Pojaviti se mora tudi velik peristaltični val skozi descendentni, sigmoidni kolon in rektum. Prisoten mora biti tudi rezervoar rektuma, da bi se v njem blato lahko zbiralo pred dokončnim izpraznjenjem ob velikem peristaltičnem valu. Na ta peristaltični val vpliva tudi gastrokolični refleks.
- In tretji mehanizem je presnova in resorpcija, ki pusti pline in blato, ki je lahko tekoče, kašasto, formirano ali trdo. Analni kanal mora biti senzorno oživčen, da bi lahko razločili med različnimi konzistencami blata kot tudi plina (3,4).

Pseudoinkontinenca nastane, kadar se v rektumu zbira trdo blato in mimo tega uhaja bolj tekoče ali vodeno blato (5).

Pri otrocih z anorektalnimi anomalijami je različno okvarjena senzibiliteta analnega kanala, kot tudi motiliteta rektosigmoidnega kolona. Ti otroci imajo različno dobro razvit sfinkterski mehanizem.

Otroci z nižjimi anomalijami imajo večjo možnost za popoln nadzor nad odvajanjem blata vendar tudi večje možnosti za zaprtost. Otroci z višjimi anomalijami pa imajo slabše možnosti za popolno kontinenco.

Pri teh otrocih ocenjujemo kontrolo nad blatom. Zavestno odvajanje ob željenem času je znak dobre kontinence. Pri inkontinenci pa je možno mazanje perila:

- I stopnje - občasno
- II stopnje - vsak dan, vendar ni socialni problem
- III stopnje - ves čas prisotno in zato problem pri socializaciji

Ali pa zaprtost:

- I stopnje - obvladljiva z dieto
- II stopnje - obvlaljiva z odvajali
- III stopnje - obvladljiva s klistiranjem.

Pri otrocih, ki so zaradi posega izgubili rezervoar rektuma, obvladamo nenehno mazanje z rednim klistiranjem in po potrebi z zdravili, ki zavirajo peristaltiko.

Vse otroke pregledamo, da bi jih razvrstili v eno od treh skupin za nadaljnjo obravnavo:

- Kandidati za reoperacijo
- Otroci, ki jih lahko priučimo kontinence
- Otroci, ki potrebujejo poseben režim odvajanja (bowel management) zaradi nezadostnega sfinkterskega mehanizma.

Pri otrocih s težavami pričnemo najprej s posebnim urnikom v katerem rezerviramo posebno uro vsak dan namenjeno odvajanju. Otroka navadimo, da si vsak dan ob isti uri vzame čas za odvajanje. Nato prilagodimo dieto, tako da starši ugotovijo katera živila otroka bolj zapirajo in katera poženejo. Omejimo živila, ki blato napravijo izrazito trdo. Prav tako iz jedilnika izbrišemo živila, ki pri otroku vedno povzročijo tekoče blato. Če z dieto ne uspemo urediti odvajanja, lahko otroku v dieto dodamo odvajala. Najprej poskusimo s tistimi, ki spremenijo resorbcijo vode v kolonu. Kasneje pa imamo na voljo še tiste, ki delujejo na motiliteto črevesa. Preparati sene jo pospešujejo, medtem ko jo loperamid ustavlja.

V kolikor ima otrok še vedno težave z uhajanjem blata se zatečemo k rednemu čiščenju kolona s pomočjo klistirjev. Le-te opravljamo z različnimi koncentracijami soli v vodi. Uporabimo lahko tudi magnezijev citrat. Lahko uporabimo tudi zdravila, ki upočasnijo peristaltiko med posameznimi klistirji.

Metode in bolniki

Do sredine leta 1997 smo pri nas klasificirali anorektalne anomalije kot nizke, intermediarne in visoke in glede na to napravili y-v plastiko ali transpozicijo anusa pri nizkih in nekaterih inetermediarnih anomalijah in pull through po Stephensu pri višjih atrezijah.

Od leta 1997 pa uporabljamo klasifikacijo po Peňi, ki opredeli tip atrezije glede na mesto kamor se odpre fistula iz rektuma. Tako med nižje anomalije uvrstimo tiste z rektoperinealno fistulo in med višje tiste z fistulo v sosednje organe. Pri deklicah so te vestibularna fistula in fistule v skupno izvodilo – kloako – s kratkim ali dolgim skupnim kanalom in anomalije brez fistule. Pri dečkih so to fistule v uretro, tako v bulbarnem delu kot v prostatičnem delu in fistule v vrat mehurja. Prav tako tudi tu obstajajo anomalije brez fistule (6).

Vse operiramo z posteriornim sagitalnim pristopom in le pri zelo visokih uporabimo še transabdominalno mobilizacijo po potrebi.

Pri nas smo od 31. januarja 2001 do 31.januarja 2011 operirali 60 otrok z anorektalnimi anomalijami. Trije otroci niso dočakali dokončne oskrbe zaradi smrti ob spremljajočih anomalijah. En otrok se ni vrnil na kontrolo po primarni oskrbi z kolostomo. Naredili smo delno posteriorno sagitalno anorektoplestiko (PSARP) pri 29 otrocih z perinealnimi fistulami in popolno PSARP pri 27 (ob zaščiti s kolostomo).

Rezultati

Vseh 29 otrok po delnem PSARP je čistih, le pri dveh so občasno potrebne spremembe v dieti in dodatki odvajal. Prav tako sta čista oba otroka, ki ob svoji anomaliji nista imela fistule. Osem deklic z vestibularno fistulo je čistih, od teh 2 potrebujeta dieto in ena odvajala ali občasni klistir. Delice s kloako smo operirali 3 s kratkim skupnim kanalom in dve z daljšim skupnim kanalom, vseh 5 je

čistih, od njih ena potrebuje odvajala, drugi dve pa klistir. Operirali smo 7 dečkov z bulbarno uretralno fistulo, ki so sedaj vsi čisti, 3 potrebujejo še medikamentozno terapijo (odvajala). Pet operiranih zaradi prostatične uretralne fistule ima večje težave. En deček kljub klistiranju še ni popolnoma čist, ostali 4 pa potrebujejo medikamentozno terapijo in vseeno občasno še mažejo.

Razprava

Pri naših bolnikih z nizkimi anomalijami so rezultati dobri, kar je razumljivo glede na to, da so pri teh otrocih prisotni skoraj normalni sfinkterski mehanizmi in je tudi njihova oživčenost normalna. Prav tako je nespremenjen rezervoar rektuma in peristaltika v njem.

Pri otrocih z višjimi anomalijami, pri katerih smo napravili PSARP vidimo, da lahko že z urnikom in dieto uredimo odvajanje, ker smo pri njih ohranili rezervoar rektuma kot tudi največji možni del delujočega sfinkterskega mehanizma in njegove oživčenosti. Le pri zelo visokih atrezijah je sfinkterski mehanizem toliko nepopoln, da potrebujejo odvajala ali pa smo morali uvesti režim rednega klistiranja.

Zaključek

Novejša metoda poprave anorektalnih anomalij daje možnost za boljšo rekonstrukcijo anorektuma znotraj sfinkterskega mehanizma. Z uporabo posebnih režimov za urejanje odvajanja lahko otroku, ki ni popolnoma kontinenten, uredimo socialno sprejemljivost, ker lahko postane »čist«. Tisti naši otroci, ki so sedaj čisti so zadovoljni, kakor so zadovoljne tudi njihove družine. Pri 5 bo potrebno še nadaljnje delo, da bi bili popolnoma čisti.

Literatura

1. Peňa A, Guardino K, Tovilla JM, Lewitt MA, Rodriguez G, Torres R. Bowel managment for fecal incontinence in patients with anorectal malformations. J Pediatr Surg 1998; 33: 133-7.
2. Paidas CN. Fecal incontinence in children with anorectal malformations. Semin Pediatr Surg 1997; 6: 228-34.
3. Paidas CN, Peňa A. Rectum and anus. In Oldham KT, Foglia RP, Colombani PM, eds. The Surgery of Infants and Children. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1997. p.117-126.
4. Donnellan WL, Holschneider AM. Chronic constipation, anal achalasia, the anterior ectopic anus. In Donnellan WL, Burrington JD, Kimura K, eds. Abdominal Surgery of Infancy and Childhood. Luxenbourg: Harwood Academic; 1996. p. 54/1 – 54/35.
5. Peňa A, El-Behery M. Megasigmoid: A source of pseudoincontinence in children with repaired anorectal malformations. J Pediatr Surg 1993; 28: 199-203.
6. Gvardijančič D, Mlakar B, Strlič M. Novosti v kirurškem zdravljenju prirojenih napak anusa in rektuma. In: Smrkolj V, ed. Zbornik predavanj XXXVII. podiplomskega tečaja kirurgije, 2001, p.76-86.